Análisis de Gestión de Calidad – Centro Médico Palmares

Módulo 2 – Técnicas y Herramientas Modernas II – Ingeniería Industrial, UNCuyo – 2026

1. Resumen ejecutivo

El Centro Médico Palmares (CMP) es una institución privada de atención médica ambulatoria ubicada en Palmares Open Mall, Mendoza. Su actividad comprende consultas de especialidad, diagnóstico por imágenes, laboratorio y vacunatorio. La gestión de calidad se analiza como una responsabilidad transversal: el resultado del servicio depende de la coordinación entre la solicitud del turno, la recepción, la validación administrativa, la atención, la entrega de resultados y el cierre económico de la prestación.

El relevamiento académico muestra una base organizativa apoyada en sistemas digitales, historias clínicas electrónicas, permisos de acceso por rol, copias de seguridad y canales diferenciados de atención. También identifica aspectos que requieren mejora: las demoras en las respuestas por WhatsApp, la duplicación de actividades administrativas entre Medexis y los sistemas de financiadores, las dificultades de segregación de residuos y un seguimiento de acciones correctivas cuyo cierre se apoya en la declaración del responsable, sin evidencia de ejecución ni comprobación posterior de eficacia.

El informe utiliza ISO 9001:2015 como referencia para organizar el análisis, sin atribuir al centro una certificación. Integra los antecedentes del caso, los trabajos académicos y los hallazgos comunicados en el proyecto. Distingue las prácticas relevadas de los riesgos potenciales y de las medidas propuestas. Las limitaciones de una revisión documental no se interpretan como incumplimientos del establecimiento.

Se propone concentrar la mejora en cuatro frentes: acceso oportuno a turnos, recepción consistente y trazable, control de condiciones de prestación y cierre verificable de las acciones correctivas. Un tablero acotado de indicadores permitiría evaluar resultados y orientar decisiones sin multiplicar registros que no aporten al servicio.

2. Caracterización del centro y alcance del análisis

a. Servicios, recursos y organización

CMP presta servicios orientados a la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de patologías. El servicio principal es la atención médica ambulatoria programada. Su ejecución requiere la participación del paciente, tanto por la información que aporta como por su asistencia y el cumplimiento de las indicaciones previas cuando la práctica las exige.

Componente	**Características relevadas**
Consultorios	30 consultorios destinados a la atención de pacientes.
Consultas	Más de 40 especialidades, para población adulta y pediátrica; determinadas especialidades realizan estudios complementarios en consultorio.
Diagnóstico por imágenes	Dos resonadores magnéticos de alto campo, un tomógrafo multicorte, ecógrafos, mamógrafo y equipos de radiología general y odontológica.
Laboratorio	Extracción en sede o a domicilio y procesamiento interno de determinaciones.
Vacunatorio	Aplicación de vacunas y registro de la prestación.
Equipo humano	Más de 190 profesionales de la salud, aproximadamente 30 empleados administrativos y 30 técnicos.
Sistemas	Medexis para funciones de gestión, historia clínica electrónica y BIOBOX para información de imágenes y resultados.

La concentración de servicios en una misma sede permite articular consultas y estudios sin que cada etapa requiera acudir a un establecimiento diferente. Esta capacidad exige coordinación: disponer de varios servicios no asegura por sí mismo la continuidad del circuito si existen fallas de comunicación, registros inconsistentes o derivaciones incorrectas.

La calidad también depende de funciones de soporte, como sistemas, mantenimiento, abastecimiento, limpieza y gestión de residuos. Algunos servicios se encuentran tercerizados. Por ello, la evaluación debe considerar tanto la prestación directa como el control de las actividades externas que afectan sus condiciones de ejecución.

b. Alcance y criterio de interpretación

El análisis comprende la organización del servicio y sus interacciones administrativas y de soporte. No constituye una evaluación de la competencia clínica individual ni de los resultados sanitarios de tratamientos. Tampoco representa una auditoría integral de cumplimiento normativo.

Se consideran tres niveles de información: características y prácticas descritas en el relevamiento; hallazgos de los trabajos y auditorías académicas; y propuestas elaboradas para mejorar el funcionamiento. Los riesgos describen acontecimientos posibles y no implican que se hayan producido

incidentes. Cuando una revisión previa no examinó un registro, esa circunstancia delimita su evidencia y no demuestra que el centro carezca de él.

3. Marco de gestión de calidad

a. Aplicación del enfoque de ISO 9001

ISO 9001:2015 permite examinar cómo una organización determina los requisitos del servicio, organiza sus procesos, controla la información y evalúa resultados. En CMP, su aplicación resulta especialmente pertinente para las interfaces: paciente–recepción, recepción–profesional, atención–resultados y prestación–financiador.

Eje de gestión	**Referencia ISO 9001:2015**	**Aplicación al caso**
Enfoque por procesos	4.4	Relacionar entradas, actividades, responsables, registros y salidas del circuito asistencial y administrativo.
Riesgos y objetivos	6.1 y 6.2	Priorizar identificación, cobertura, trazabilidad, oportunidad de respuesta y condiciones de prestación.
Competencia e información	7.2 y 7.5	Asegurar comprensión de tareas, instrucciones vigentes y registros protegidos y recuperables.
Requisitos del servicio	8.2	Comunicar preparación, condiciones del turno, documentación y cobertura antes de la atención.
Prestadores externos	8.4	Establecer criterios de control para servicios contratados que afectan la calidad.
Prestación y trazabilidad	8.5	Mantener correspondencia entre paciente, turno, práctica, registro y resultado.
Evaluación del desempeño	9.1 y 9.2	Analizar indicadores, percepción del paciente y evidencia de auditoría.

Eje de gestión	Referencia ISO 9001:2015	Aplicación al caso
Acción correctiva	10.2	Corregir desvíos, analizar causas y comprobar la eficacia de las acciones.

La vinculación con estos apartados es metodológica. La existencia de software o de un mapa de procesos no acredita por sí sola la conformidad con la norma: interesa cómo se utilizan, qué controles sostienen y qué resultados permiten demostrar.

b. Planificación, aseguramiento, control y mejora

La planificación define requisitos, recursos y objetivos. El aseguramiento de calidad establece condiciones organizadas que proporcionan confianza en el cumplimiento: instrucciones, competencias, responsabilidades y registros. El control comprueba resultados concretos, como la coincidencia de los datos del paciente o la condición de un consultorio antes de su utilización. La mejora actúa sobre las causas de los desvíos y verifica los efectos de la intervención.

En recepción, por ejemplo, una instrucción para verificar identidad integra el aseguramiento; la comprobación efectuada durante una admisión constituye control; y la modificación del método después de analizar errores representa mejora. Los tres componentes requieren conexión. Un control sin criterios produce decisiones inconsistentes; un procedimiento sin aplicación no asegura resultados; una acción sin verificación no demuestra mejora.

El proyecto también aborda la integración de calidad, ambiente y seguridad y salud en el trabajo. Para CMP, esa integración tiene aplicaciones concretas en limpieza, residuos patogénicos, exposición a agentes de riesgo y supervisión de contratistas. Los compromisos formulados académicamente deben entenderse como propuestas para la organización, no como políticas institucionales ya aprobadas.

4. Procesos y circuito del paciente

a. Estructura de procesos

El mapa general desarrollado para el caso organiza las actividades en procesos estratégicos, operativos y de soporte. La entrada principal es una necesidad de atención, acompañada por los requisitos del paciente y de su financiador. La salida integra la prestación realizada, su registro y, cuando corresponde, el resultado entregado y la facturación asociada.

Grupo	Procesos comprendidos	Contribución a la calidad
Estratégicos	Dirección y planificación; incorporación de especialidades y profesionales; gestión de	Orientar los servicios, asignar recursos y establecer condiciones de funcionamiento.

Grupo	Procesos comprendidos	Contribución a la calidad
	calidad; convenios con financiadores.	
Operativos	Turnos; recepción y validación; atención; entrega de resultados; facturación y cobranza; liquidación a profesionales.	Transformar la solicitud en una prestación realizada y documentada.
Soporte	Personal administrativo; gestión de profesionales; sistemas; compras; mantenimiento; bioseguridad y residuos; supervisión de limpieza.	Sostener recursos, información y condiciones para la atención.

Esta clasificación permite analizar responsabilidades sin aislar actividades. La facturación depende del registro de la prestación y de la autorización; la entrega de resultados depende de la correcta identificación y de los datos de contacto; la atención depende de la disponibilidad del profesional y del equipamiento.

b. Desarrollo del circuito

Solicitud y asignación del turno. El paciente accede mediante web, teléfono o WhatsApp diferenciado por sector. La atención de estos canales corresponde a personal propio. El sistema emite recordatorios e incluye indicaciones de preparación cuando la prestación lo requiere. El horario relevado de WhatsApp para Centro e Imágenes es de 8 a 21 horas; este dato describe la disponibilidad del canal y no un tiempo garantizado de respuesta.

Llegada y recepción. La modalidad depende de la cobertura, la prestación y la puntualidad. Los pacientes con cobertura OSDE que concurren en horario a consulta de especialidad pueden autorecepcionarse mediante DNI en una terminal. El sistema valida la cobertura, emite un ticket y orienta al paciente mediante señalética. Las demás coberturas, los particulares y las prestaciones que requieren recepción presencial siguen el circuito administrado por el personal.

Tratamiento de excepciones. Si el paciente llega con demora, recepción consulta la posibilidad de atención con el profesional. Cuando no resulta posible, se ofrece una reprogramación. Si no figura un turno, se propone una alternativa. Los pacientes particulares pasan por caja antes de la consulta. Estas variantes muestran que la recepción debe resolver situaciones diferentes con criterios consistentes.

Atención y registro. El paciente se dirige al sector indicado y recibe la prestación. El profesional registra la atención en la historia clínica electrónica y emite receta electrónica cuando corresponde. Si se necesita una nueva consulta o estudio, se gestiona otro turno. La trayectoria no es estrictamente lineal: puede incluir varias prestaciones relacionadas.

Resultados y cierre. Los informes se entregan por medios digitales, incluidos correo electrónico y BIOBOX; también se releva acceso mediante QR. Se describen plazos aproximados de dos a tres días para imágenes y una semana para laboratorio. Son referencias del relevamiento, no estándares formales ni garantías para toda práctica. El cierre administrativo comprende facturación a financiadores, tratamiento de débitos y liquidación a profesionales; para particulares, el cobro ocurre previamente a la atención.

c. Requisitos críticos de recepción

El plan académico de aseguramiento sintetiza cinco requisitos para organizar el control del ingreso. Sus códigos son identificadores del trabajo y no denominaciones de la norma ISO.

Código	**Requisito**	**Propósito del control**
R1	Identificar correctamente al paciente.	Evitar registros o selección de personas equivocadas.
R2	Asegurar coincidencia entre paciente, turno y prestación.	Vincular la solicitud con el servicio que corresponde realizar.
R3	Contar con cobertura y documentación válidas o alternativa autorizada.	Resolver condiciones administrativas antes de continuar el circuito.
R4	Mantener un registro administrativo trazable.	Reconstruir qué se hizo, cuándo y quién intervino.
R5	Derivar al paciente al sector correcto.	Evitar recorridos y esperas ocasionados por una orientación incorrecta.

La separación facilita el análisis, pero los requisitos deben cumplirse de manera conjunta. Una cobertura válida no compensa una identificación incorrecta; una derivación adecuada tampoco reemplaza el registro de la operación.

5. Diagnóstico de la gestión de calidad

a. Capacidades relevadas

CMP dispone de herramientas digitales para agendas, turnos, facturación, historia clínica y resultados. Se informan permisos diferenciados por rol y copias de seguridad. También se describe conservación de historias clínicas digitales durante diez años. Estos elementos constituyen capacidades para gestionar la información y reconstruir la atención; su eficacia depende de la consistencia de uso y de los controles de acceso y recuperación.

La recepción contempla variantes por cobertura y prestación, mientras que los recordatorios y la entrega digital permiten anticipar información y reducir gestiones presenciales. La incorporación de profesionales incluye control y registro de matrículas. En soporte, se encuentran identificadas funciones de mantenimiento, limpieza y retiro especializado de residuos.

Estas capacidades deben valorarse sin convertirlas en resultados no medidos. La existencia de autorecepción, por ejemplo, puede aliviar la carga administrativa en determinados casos, pero no permite cuantificar una reducción de espera sin comparar registros.

b. Aspectos que requieren intervención

Aspecto	**Evidencia o situación relevada**	**Implicación para la gestión**
Respuesta por WhatsApp	Las demoras aparecen como problema de acceso en el análisis del caso.	Conviene medir la espera de respuesta y la resolución de solicitudes antes de reorganizar recursos.
Recepción integrada	Se identifica duplicación de tareas entre Medexis y sistemas de obras sociales.	La repetición incrementa carga administrativa y crea riesgo de inconsistencias entre registros.
Cierre de acciones correctivas	El responsable actualiza la tarea a “completada”; existen alertas para pendientes, pero no se exige evidencia ni comprobación posterior.	El sistema permite seguir estados, aunque el cierre no demuestra ejecución correcta ni eficacia.
Segregación de residuos	La auditoría académica señala segregación deficiente.	Deben precisarse los sectores afectados y comprobar la aplicación de las medidas correctivas.
Evidencia de auditoría	Algunas casillas carecen de observaciones o respaldo.	Una casilla vacía no permite concluir conformidad ni incumplimiento; corresponde mejorar el registro de evidencia.

La situación de las acciones correctivas merece atención prioritaria porque afecta el mecanismo utilizado para resolver otros problemas. Si una tarea se cierra únicamente por declaración, el desvío puede reaparecer sin que el sistema lo detecte como falla de la solución adoptada.

c. Información, continuidad y servicios externos

Los resultados digitales y la historia clínica requieren controles en cada intercambio. El relevamiento describe accesos por rol y respaldos, pero las revisiones anteriores no comprobaron todos los mecanismos de validación del destinatario, protección del QR o tratamiento de correos incorrectos. Se propone revisar estos puntos como controles del proceso, sin atribuir incidentes de divulgación de datos.

La continuidad también depende de equipos disponibles y de condiciones adecuadas de los consultorios. La habilitación de un equipo y la ejecución de mantenimiento son cuestiones diferentes; el control de calidad debe considerar los registros pertinentes y las condiciones reales de uso. Del mismo modo, contratar limpieza o retiro de residuos no reemplaza la verificación del servicio recibido.

En relación con los profesionales, el control de matrícula al ingreso puede complementarse con revisiones de vigencia. En capacitación administrativa interesa verificar la comprensión y aplicación de criterios de identidad, cobertura, confidencialidad y tratamiento de excepciones, además de conservar constancias de formación.

6. Problemas, riesgos y análisis de causas

a. Priorización cualitativa

Se propone priorizar según el efecto sobre el paciente, la integridad de la información y la posibilidad de repetición. La siguiente matriz constituye una herramienta de trabajo, sin asignar probabilidades ni frecuencias que no fueron medidas.

Riesgo o problema	**Efecto posible**	**Medida de aseguramiento propuesta**
Selección de un registro incorrecto o duplicado	Vinculación de la atención con otra persona.	Buscar antecedentes y verificar concordancia de nombre completo y DNI; incorporar confirmación asistencial independiente.
Discordancia entre turno y prestación	Preparación o derivación inadecuada.	Verificar la práctica solicitada y sus requisitos antes de completar la recepción.
Cobertura o autorización inconsistente	Demoras, reprocesos y dificultades de facturación.	Establecer criterios de validación y documentar las alternativas autorizadas.
Doble carga administrativa	Inconsistencias y mayor tiempo de recepción.	Mapear datos repetidos, reducir duplicaciones y evaluar integración técnica.

Riesgo o problema	**Efecto posible**	**Medida de aseguramiento propuesta**
Cierre sin evidencia de una acción correctiva	Persistencia del problema bajo un estado de tarea completada.	Separar ejecución, verificación y evaluación de eficacia.
Segregación incorrecta de residuos	Mezcla de residuos y exposición de quienes los manipulan.	Revisar recipientes y señalización, capacitar y controlar la segregación en el lugar de generación.

Los riesgos de identificación se consideran relevantes por sus consecuencias potenciales; no se afirma que el centro haya realizado atenciones a pacientes equivocados. La prioridad preventiva puede justificarse por la gravedad del efecto, aunque no se disponga de una frecuencia de incidentes.

b. Causas y mecanismos a comprobar

Para WhatsApp, se propone analizar la distribución horaria de solicitudes, la asignación de conversaciones, los criterios de prioridad y la cantidad de intercambios necesaria para resolver una gestión. Estos factores son hipótesis de trabajo. Atribuir la demora únicamente a falta de personal sin medir demanda y capacidad podría conducir a una intervención costosa e ineficaz.

En recepción, la duplicación entre sistemas constituye un mecanismo concreto de reproceso. Debe distinguirse qué datos se repiten por exigencias del financiador, cuáles podrían reutilizarse y cuáles requieren confirmación independiente. La integración debe preservar verificaciones necesarias, no limitarse a acelerar la carga.

En acciones correctivas, la debilidad identificada está en el criterio de cierre: actualizar un estado reemplaza la demostración de ejecución. La alerta actúa sobre tareas pendientes, pero deja de ser útil cuando la tarea se declara completa sin comprobación. La mejora requiere modificar ese criterio y asignar una función de verificación.

En residuos, la segregación deficiente justifica examinar disposición de recipientes, claridad de instrucciones, disponibilidad de insumos y comportamiento en cada sector. Estos elementos deben contrastarse mediante observación; el hallazgo no permite atribuir una causa única ni responsabilizar automáticamente al personal de limpieza.

7. Propuestas de mejora y aplicación

a. Acceso a turnos y recepción integrada

Se propone registrar el momento de ingreso de cada solicitud por WhatsApp, su primera respuesta humana y su resolución. La primera respuesta debe aportar atención efectiva: un mensaje automático de recepción no debería contabilizarse como resolución ni ocultar la espera real. El análisis por sector y

franja horaria permitiría redistribuir tareas y establecer objetivos de respuesta compatibles con la demanda observada.

Para recepción, se recomienda documentar un circuito común y sus variantes: autorecepción, otras coberturas, particulares, demoras y ausencia de turno. La fila virtual puede evaluarse como propuesta para ordenar el acceso y comunicar el avance, evitando presentarla como solución suficiente si persiste la doble carga.

La integración administrativa debe comenzar por un relevamiento de campos y validaciones entre Medexis y financiadores. Se propone ensayar cambios en un circuito acotado, comparar tiempos y errores, y ampliar únicamente si se preservan los requisitos R1 a R5. La automatización debe incorporar permisos, trazabilidad y tratamiento de excepciones.

b. Cierre verificable de acciones correctivas

Se propone reemplazar el cierre basado en una sola declaración por una secuencia con responsabilidades diferenciadas:

- **Registrar el desvío:** describir lo ocurrido, el requisito afectado y la evidencia disponible.
- **Corregir y analizar:** atender la consecuencia inmediata y determinar las causas que requieren intervención.
- **Ejecutar la acción:** registrar responsable, actividad realizada y evidencia pertinente.
- **Verificar la ejecución:** comprobar que la medida se implementó como fue prevista.
- **Evaluar la eficacia:** revisar, tras un período o conjunto de casos adecuado, si el problema disminuyó o dejó de repetirse.
- **Cerrar o reformular:** conservar el resultado de la revisión y reabrir el análisis cuando la medida no resulte eficaz.

La evidencia puede ser un registro del sistema, una observación documentada, una instrucción actualizada o un resultado de control. No toda tarea requiere una fotografía: el respaldo debe demostrar aquello que se pretende verificar. También se propone conservar alertas para verificaciones pendientes, además de las correspondientes a ejecución.

c. Condiciones de prestación y control de servicios

Se recomienda establecer una verificación de disponibilidad y condición de los consultorios, coherente con la especificación trabajada en el proyecto. Si un espacio no reúne las condiciones requeridas, debe identificarse su restricción, comunicarse a quien coordina la atención y comprobarse la corrección antes de autorizar nuevamente su uso. Esta liberación constituye una propuesta de control interno; no presupone la contratación de un inspector externo.

Para residuos, se propone intervenir en el punto donde se generan: recipientes adecuados, identificación comprensible e instrucciones consistentes entre sectores. La verificación debe observar la segregación

real, además de revisar capacitación y documentación del retiro. Para limpieza, conviene relacionar tareas, sectores, frecuencia y registros de supervisión. En mantenimiento, debe vincularse cada intervención con el equipo, la condición encontrada y la autorización de uso que corresponda.

d. Secuencia de implementación sugerida

Etapa propuesta	**Actividades**	**Roles sugeridos**	**Evidencia de avance**
Organización	Acordar criterios de cierre de acciones y definiciones de indicadores; seleccionar un circuito piloto.	Dirección, Calidad y responsables de sectores.	Criterios aprobados y ficha de cada indicador.
Aplicación inicial	Medir WhatsApp y recepción; probar verificación de acciones; revisar segregación y condiciones de consultorios.	Recepción, sistemas, responsables asistenciales y soporte.	Registros del piloto y verificaciones efectuadas.
Evaluación	Comparar resultados, analizar desvíos y ajustar métodos.	Calidad y responsables de procesos.	Decisiones sustentadas y acciones revisadas.
Consolidación	Extender medidas eficaces e incorporarlas a la operación y a auditorías posteriores.	Dirección y áreas involucradas.	Instrucciones actualizadas y seguimiento sostenido.

Los roles se sugieren por su relación funcional con las tareas y no representan nuevas designaciones institucionales. La secuencia permite aprender de una aplicación acotada antes de ampliar cambios a todos los servicios.

8. Indicadores propuestos para seguimiento

El tablero debe permitir distinguir actividad de resultado. Contar mensajes respondidos informa volumen, pero no describe cuánto esperó el paciente; contar tareas completadas no demuestra que una acción haya sido eficaz. Se proponen indicadores vinculados con los problemas y controles del informe.

Indicador propuesto	**Definición operativa**	**Fuente y revisión sugeridas**
Tiempo de primera respuesta por WhatsApp	Mediana del tiempo entre solicitud y primera respuesta humana; informar por separado tiempo calendario y tiempo dentro del horario de atención.	Marcas temporales del canal; revisión semanal por sector.
Solicitudes de turno resueltas	Solicitudes con respuesta final documentada / solicitudes recibidas en la cohorte analizada × 100.	Registro de conversaciones; seguimiento semanal, incluyendo casos aún abiertos.
Tiempo de recepción presencial	Mediana del tiempo entre inicio y finalización de la gestión; separar circuitos y excepciones.	Observación o marcas del sistema; revisión durante el piloto y luego mensual.
Recepciones con reproceso	Recepciones que requirieron corregir o repetir una gestión por inconsistencia / recepciones revisadas × 100.	Registro de incidencias y muestra identificada; revisión mensual.
Trazabilidad administrativa completa	Registros revisados que permiten reconstruir identidad, prestación e intervención / registros revisados × 100.	Muestra de registros administrativos; revisión mensual.
Acciones con ejecución verificada	Acciones declaradas ejecutadas con verificación y evidencia / acciones declaradas ejecutadas × 100.	Plan de acciones; revisión mensual.
Acciones correctivas eficaces	Acciones evaluadas que cumplieron el criterio de eficacia / acciones evaluadas en el período × 100.	Evaluaciones documentadas; seguimiento mensual de las revisiones realizadas.
Segregación conforme	Puntos observados con segregación correcta / puntos observados × 100.	Lista de observación por sector; frecuencia inicial semanal.
Satisfacción con la gestión administrativa	Respuestas favorables / respuestas válidas × 100, indicando escala y número de participantes.	Encuesta breve posterior a la gestión; análisis mensual.

Las frecuencias son recomendaciones de implementación. Las metas deben establecerse después de construir una línea de base y considerar capacidad, criticidad y expectativas del paciente. Los tiempos

promedio de entrega de resultados descritos en el relevamiento no deben utilizarse automáticamente como límites de conformidad.

Cada ficha debe precisar responsable de medición, alcance, exclusiones y criterio de cálculo. Para muestras se debe informar su tamaño y método de selección, evitando extrapolar porcentajes sin sustento. Si no existen casos en un denominador, no corresponde informar un resultado artificial de cero o cien por ciento. Los registros del tablero deben utilizar datos agregados y restringir el acceso a información identificable.

El seguimiento debe terminar en decisiones: reasignar capacidad, modificar instrucciones, corregir una integración o revisar una acción. Cuando un indicador mejora, corresponde comprobar que no se deterioró otro requisito; una recepción más rápida no representa mejora si aumenta el reproceso o debilita la identificación.

9. Conclusiones

La gestión de calidad de CMP se apoya en una oferta ambulatoria integrada, herramientas digitales y funciones de soporte identificadas. Su principal desafío analizado reside en articular esas capacidades para que cada prestación mantenga coherencia entre identidad, turno, cobertura, atención, resultado y registro administrativo.

El diagnóstico orienta la intervención hacia problemas concretos: oportunidad de respuesta por WhatsApp, duplicación de tareas de recepción, segregación de residuos y verificación insuficiente del cierre de acciones correctivas. También distingue riesgos preventivos de incidentes comprobados y evita interpretar una revisión documental incompleta como evidencia de incumplimiento.

La propuesta central consiste en incorporar evidencia al funcionamiento cotidiano: verificar requisitos críticos en recepción, medir los puntos de espera, controlar condiciones de prestación y separar ejecución de eficacia en las acciones correctivas. Esta última mejora fortalece el sistema completo, porque permite comprobar si las intervenciones resuelven los problemas que las originaron.

La aplicación gradual, con indicadores definidos y revisión de resultados, permitiría sostener decisiones sobre información comparable. El valor del enfoque no reside en aumentar la cantidad de documentos, sino en contar con registros suficientes para coordinar la atención, demostrar controles y orientar mejoras verificables.